بسم الله الرحمن رحیم

تغذیه در مراقبت‌های بهداشتی

دکتر بهارک آقاپور

استادیار دانشگاه علوم پزشکی سراب

پاییز
۱۴۰۵

نظام سلامت

- **تعریف سلامت:** احساس خوب بودن و در واقع سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی (چیزی بیش از غایب بودن بیماری)
- **نظام سلامت:** عبارت است از سازمان‌ها، موسسات و منابعی که فعالیت‌هایشان با هدف اولیه ارتقاء سلامت باشد.
- **نظام مراقبت سلامت:** موسسات، منابع و افرادی است که در ارائه خدمات و مراقبت سلامت به افراد و جامعه دخالت دارند.
- این خدمات مي‌تواند به صورت هرگونه تلاشي که خواه در مراقبت سلامت فردي ـ خدمات بهداشت عمومي و یا از طریق برنامه هاي بين بخشي انجام می‌گیرد، تعریف شود و **هدف اصلي آن ارتقاء سلامت** است.

اصول مراقبت‌های بهداشتی اولیه شامل:

1- برابری توزیع یا عادلانه بودن توزیع خدمات

خدمات بهداشتی باید بدون توجه به توانایی پرداخت مردم بین همه آن‌ها یکسان توزیع شود و همه به خدمات بهداشتی دسترسی داشته باشند.

2- مشارکت جامعه

- **مشارکت افراد و خانواده‌ها در ارتقا سلامتی خود، صرف نظر از مسئولیت دولت، یک بخش ضروری از مراقبت‌هاست.**
- **بدون مداخله جامعه نمی‌توان به پوشش کامل و جامع مراقبت‌های بهداشتی اولیه دست یافت.**

3- هماهنگی بین بخشی

- **بهداشت تحت تاثیر ترکیبی از عوامل محیطی اجتماعی و اقتصادی است که با یکدیگر ارتباط تنگاتنگ دارند.**
- **مراقبت‌های بهداشتی اولیه تنها با بخش بهداشت فراهم نمی‌شود. سایر بخش‌های مرتبط با توسعه جامعه از قبیل بخش کشاورزی، آموزش، مسکن، ارتباطات و ... باید در مراقبت‌های بهداشتی اولیه درگیر شوند.**

ادامه‌ی اصول مراقبت‌های بهداشتی اولیه...

- **دولت‌ها باید جهت اطمینان از این هماهنگی مقررات ویژه‌ای وضع کنند و با برنامه‌ریزی مناسب از کم کاری و یا دوباره‌کاری غیرضروری پرهیز کنند.**

4- فناوری مناسب

- **منظور فناوری معتبر علمی و قابل انطباق با نیازهای محلی و قابل پذیرش توسط ارائه‌کنندگان و گیرندگان خدمت است که با اتکا بر منابع جامعه و با بهایی قابل پرداخت توسط کشور قابل نگهداری باشد.**
- **به طور خلاصه فناوری مناسب ترکیبی است که هم نیازهای مراقبت بهداشتی و هم بافت اقتصادی اجتماعی کشور را در نظر می‌گیرد.**

ادامه‌ی اصول مراقبت‌های بهداشتی اولیه...

5- جامعیت خدمات

مراقبت‌های بهداشتی اولیه یک رویکرد جامع است به عبارتی رویکرد جامع مراقبت‌های بهداشتی اولیه نیازمند استفاده از کارکنانی است که بتوانند در برخورد با مشکلات راه حل جامع ارائه دهند.

مثال: برای کودک مبتلا به اسهال تنها مایع درمانی خوراکی کافی نیست. نگهداری سلامت کودک نیازمند ارائه آموزش به خانواده، بهداشت محیط و بهبود تغذیه است.

3 اصل درمان در منزل باید به مادر آموزش داده شده شامل: 1- دادن مایعات اضافی 2- ادامه تغذیه (غذاهای آبکی) 3- زمان مراجعه مجدد

6- تعهد سیاسی دولت

دولت‌ها مسئولیت مهم و اصلی را در زمینه دستیابی به سلامت دارند و در این زمینه باید مسئولیت‌پذیر باشند.

اجزای مراقبت‌های بهداشتی اولیه

- آموزش بهداشت
- تغذیه مناسب
- تامین آب کافی و سالم و بهسازی محیط
- مراقبت بهداشتی مادر و کودک و تنظیم خانواده
- ایمن‌سازی علیه بیماری‌های عمده عفونی
- پیشگیری از بیماری‌های بومی شایع و کنترل آن‌ها
- درمان مناسب بیماری و حوادث شایع
- تدارک داروهای اساسی
- بهداشت دهان و دندان
- بهداشت روان
- آمادگی مقابله با بلایای طبیعی


آموزش مردم
بهبود وضعیت غذا و تغذیه
تامین آب آشامیدنی سالم
ایمنسازی بر علیه بیماری‌های عفونی
بهداشت مادر و کودک
مبارزه با بیماری‌ها
درمان مناسب بیماری‌ها و حوادث
تدارک داروهای اساسی
سطح اول ارجاع
سطح دوم ارجاع
سطح سوم ارجاع
عدالت
مشارکت جامعه
همکاری بین بخشی

واحدهای ارائه خدمات سلامت در کشور

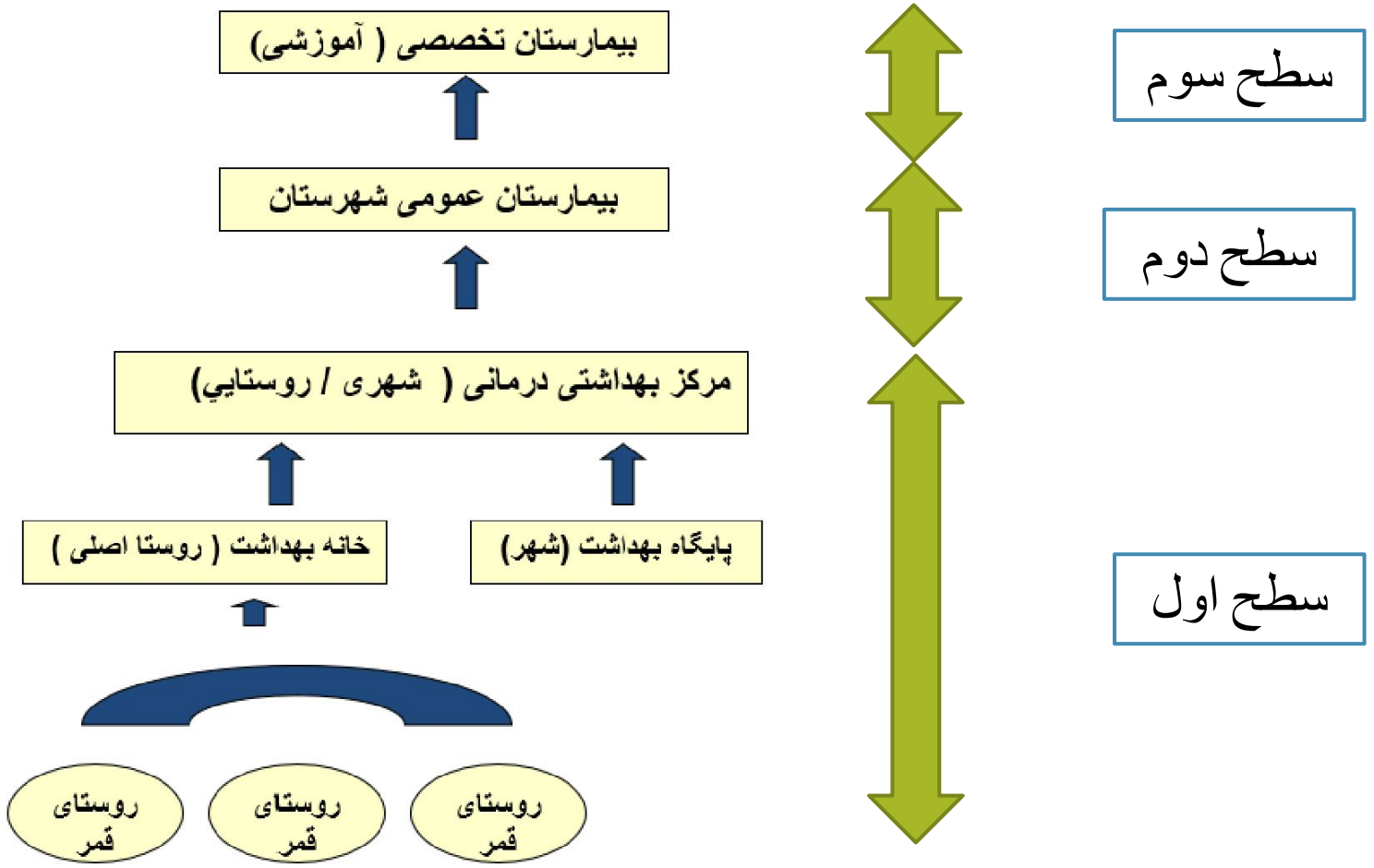
- **خانه بهداشت**
- **پایگاه بهداشت روستایی**
- **پایگاه ضمیمه (در داخل مرکز مستقر هستند و اطلاعات آن در داخل مرکز بهداشتی درمانی شهری وارد می‌شود)**
- **پایگاه غیرضمیمه**
- **مرکز بهداشتی درمانی روستایی**
- **مرکز بهداشتی درمانی شهری**
- **مرکز شبانه‌روزی روستایی درجه 1 و 2**
- **مرکز شبانه‌روزی شهری درجه 1 و 2**

ادامه‌ی واحدهای ارائه خدمات سلامت در کشور...



- تسهیلات زایمانی
- مرکز بهداشت شهرستان
- درمانگاه
- کلینیک
- پلی‌کلینیک
- بیمارستان
- توانبخشی
- مرکز طب کار و خانه بهداشت کارگری

سطوح ارائه خدمات شبکه بهداشتی درمانی دانشگاهی و نظام ارجاع



- **روستای اصلی**

این روستا طبق شرایط طرح گسترش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، ممکن است دارای مرکز بهداشتی درمانی روستایی باشد ولی دارای خانه بهداشت یا پایگاه بهداشت روستایی است. این روستا، روستای اصلی نام دارد ولی محل استقرار مرکز بهداشتی درمانی نمی‌باشد. روستای اصلی، روستای محل استقرار خانه بهداشت است.

- **روستای قمر**

این روستا طبق دفترچه‌های طرح گسترش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، محل استقرار مرکز بهداشتی درمانی روستایی یا خانه بهداشت نبوده ولی تحت پوشش خانه بهداشت می‌باشد که به آن، روستای قمر گویند.

- **جمعیت سیاری**

به روستاهایی با جمعیت کم و به فاصله بیش از یکساعت پیاده‌روی (حدود 6 کیلومتر) از خانه بهداشت، که خدمات به این روستاها توسط تیم سیار انجام می‌شود، روستای سیار گفته می‌شود.

- **جمعیت مستقیم**

جمعیتی از روستا که نزدیک آن قرار دارد، این روستاها که در حاشیه شهرها واقع شده‌اند جمعیت قابل توجهی ندارند و اغلب بدون واسطه خانه بهداشت تحت پوشش یک مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی قرار دارند.

ضرورت بکارگیری نظام ارجاع

- **راهی برای برخورداری سهل‌تر نیازمندان واقعی از امکانات بهداشتی درمانی کشور**
- **وسیله‌ای برای توزیع عادلانه منابع بهداشتی و گامی در مسیر عدالت اجتماعی**

اهداف طرح تحول نظام سلامت در حوزه تغذیه

۱. افزایش دسترسی خانواده ها به خدمات آموزشی و پیشگیرانه تغذیه جامعه، با دو رویکرد پیشگیری و کنترل عوامل خطر تغذیه‌ای بیماری های غیر واگیر، سوء تغذیه و کمبود ریزمغذی ها

۲. افزایش بهره مندی مردم از خدمات کارشناسان تغذیه در قالب سیستم ارجاع

۳. گسترش طیف خدمات تغذیه پیشگیرانه قابل دسترسی در سطح اول ارائه خدمات و ارجاع به کارشناس تغذیه در موارد نیازمند به مشاوره تغذیه

۴. تقویت ارتباط بین خدمات سطح اول و سطوح بالاتر (به ویژه بین تیم سلامت و کارشناسان تغذیه)

۵. انتقال اطلاعات لازم از نحوه ارایه خدمات و پی گیری موارد ارجاع داده شده

مراقبت‌های تغذیه‌ای برنامه تحول سلامت

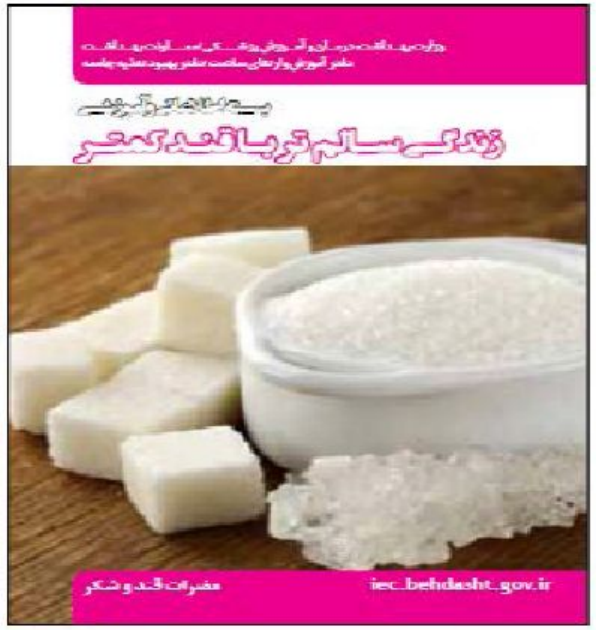
- ارائه خدمات پیشگیرانه و مراقبت‌های تغذیه‌ای شامل: آموزش تغذیه سالم و پیشگیری از بیماری‌های مرتبط با تغذیه
- خدمات به صورت آموزش چهره به چهره، مشاوره، جلسات آموزشی گروهی، مراقبت تغذیه‌ای و مداخلات تغذیه‌ای جامعه محور
- افراد مراجعه‌کننده به پایگاه سلامت توسط مراقبت سلامت مورد ارزیابی‌های اولیه تغذیه‌ای قرار می‌گیرند، سپس افرادی که نیازمند مشاوره تغذیه و دریافت خدمات بیشتر هستند به کارشناس تغذیه ارجاع داده می‌شوند تا مراقبت‌های تغذیه‌ای دریافت کنند.

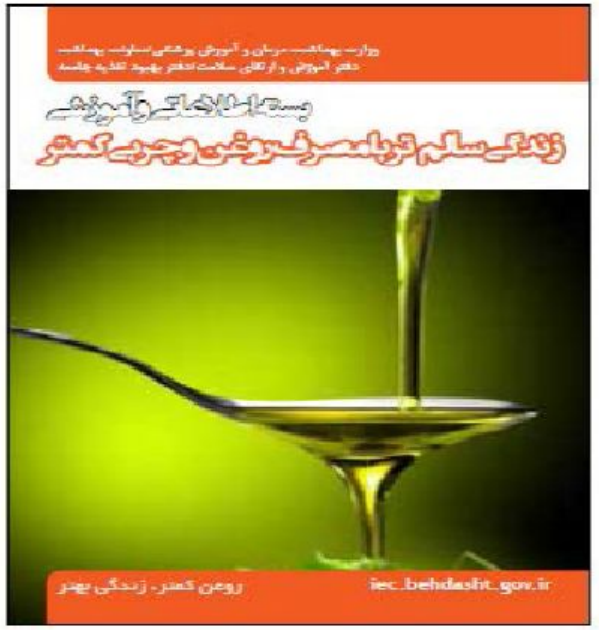

بسته آموزشی تغذیه
(ویژه مراقب سلامت)
بسته آموزشی و مشاوره تغذیه
(ویژه کارشناس تغذیه)
بسته خدمت تغذیه
(ویژه مراقب سلامت، کارشناس تغذیه و پزشک)




سرطان
پیشگیری از آن با اصلاح الگوی غذایی
نشانگرهای رنگی تغذیه‌ای
راهنمایی مطمئن


بیماری نه
بیشتر از ۵ گرم
در روز نمک نخورید
همیشه برچسب
محصولات غذایی را
بخوانید.
بسته اطلاعاتی و آموزشی
نمک کمتر، زندگی بهتر
iec.behdasht.gov.ir


زندگی سالم تر با قند کمتر
iec.behdasht.gov.ir


زندگی سالم تر با مصرف روغن وجربی کمتر
iec.behdasht.gov.ir


پیام‌های کلیدی سلامتی
قلبی-عروقی
دیابت
راز سلامتی
و پیشگیری از بیماری‌ها با اصلاح الگوی غذایی


نمک کمتر، زندگی سالم‌تر
کاهش مصرف نمک
بیایید با مصرف کمتر نمک، به طول عمر خود بیافزاییم
ایست
آیا می دانید؟
مصرف زیاد نمک موجب ابتلا به فشارخون بالا، بیماری‌های قلبی- عروقی، سکته مغزی، سرطان و پوکی استخوان می‌شود.
همه مواد غذایی دارای سدیم (نمک پنهان) هستند، مواظب "نمک پنهان" باشید.
کودکان را باید از ابتدای کودکی به غذای کم نمک عادت داد.
انواع فست فودها و کنسروها حاوی مقادیر زیادی نمک هستند.
برای بهبود طعم غذا به جای نمک از سبزی‌های معطر، آب لیمو ترش و نارنج تازه استفاده کنید.


روغن کمتر
زندگی سالم‌تر
کاهش مصرف
روغن و چربی های خوراکی
روغن جامد
بیایید با مصرف کمتر روغن و چربی های خوراکی به طول عمر خود بیافزاییم
ایست
آیا می دانید؟
برای پیشگیری از چاقی، بیماری‌های قلبی و عروقی، دیابت و سرطان ها مصرف انواع روغن و چربی را کاهش دهید.
از گوشت، شیر و لبنیات کم چرب استفاده کنید.
مصرف غذاهای آماده (فست فود)، سس‌های چرب و تنقلاتی مانند چیپس را کاهش دهید.
روغن را به طور مستقیم از داخل بطری به درون ظرف غذا نریخته و آن را با قاشق اندازه‌گیری نمایید.
هنگام خرید روغن به برچسب آن دقت کنید تا میزان اسید چرب ترانس آن کمتر از ۲٪ باشد.
به جای غذاهای سرخ شده، از غذاهای آب‌پز، بخارپز و کبابی بیشتر استفاده کنید.
از روغن مخصوص سرخ کردنی فقط برای مصارف سرخ کردن استفاده کنید.

افراد نیازمند به خدمات تغذیه‌ای:

۱. کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلالات رشد (اعم از کم وزنی، لاغری، کوتاه قدی، اضافه وزن و چاقی)

۲. جوانان مبتلا به اضافه وزن مطابق با دستور عمل، و یا دارای امتیاز نامطلوب در ارزیابی الگوی تغذیه مطابق با دستور عمل

۳. میانسالان مبتلا به اضافه وزن مطابق با دستورعمل، و یا میانسالان با دور کمر نامطلوب، و یا امتیاز نامطلوب در ارزیابی الگوی تغذیه مطابق با دستور عمل

۴. مادران باردار مبتلا به اضافه وزن، لاغری و کم خونی (ارجاع از طرف پزشک)

۵. سالمندان در معرض و یا مبتلا به سوء تغذیه براساس امتیاز ارزیابی الگوی تغذیه مطابق با دستور عمل

۶. کلیه مبتلایان به چاقی، دیابت، فشارخون بالا و دیس لیپیدمی در تمامی گروه های سنی و فیزیولوژیک

۷. سایر بیماری ها به غیر از چاقی، دیابت، فشارخون بالاو دیس لیپیدمی که از طریق پزشک ارجاع شده اند و نیاز به مشاوره تغذیه دارند.

کلیه افراد ارجاع داده شده به کارشناس تغذیه پس از دریافت مشاوره و آموزش های لازم توسط کارشناس تغذیه چنانچه نیازمند خدمات تخصصی تغذیه باشند به سطح بالاتر (مرکز مشاوره خارج از مرکز سلامت جامعه) ارجاع داده می‌شوند.

مواردی که نیازمند خدمات تخصصی است به شرح زیر می‌باشد:

۱. کلیه بیماران به غیر از مبتلایان به چاقی، دیابت، فشارخون بالا و دیس لیپیدمی که به طور معمول از طرف پزشک به کارشناس تغذیه ارجاع می شوند.

۲. کلیه افرادی که همراه با چاقی، دیابت، فشارخون بالاو دیس لیپیدمی، به طور هم زمان مبتلا به بیماری دیگری مانند بیماری های کلیوی، ریوی، گوارشی و ... می باشند. مانند فرد مبتلا به دیابت که که مبتلا به بیماری کلیوی (نفروپاتی) نیز می باشد.

۳. موارد سوء تغذیه شدید که به تشخیص پزشک نیاز به بستری شدن در بیمارستان ندارد.

ابزار و ملزومات ارائه خدمات تغذیه‌ای در اتاق مراقبت سلامت

- تجهیزات شامل: ترازوی بزرگسال، ترازوی کودک، قدسنج بزرگسال، قدسنج کودک، متر نواری، وزنه شاهد،کامپیوتر، ماشین حساب، کارت رشد کودک و نوجوان، نمودار وزن گیری مادر باردار، نوموگرام، قفسه یا فایل جهت نگهداری مدارک، برگه ارجاع و بازخورد مراقبت تغذیه ای، کلیه فرم های ارزیابی تغذیه ای مراقب سلامت، پی گیری و گزارش گیری، دفاتر ثبت مراجعین
- مکمل‌ها شامل: اسید فولیک، مولتی ویتامین مینرال ید دار، قرص و قطره آهن، قطره A+D، قطره مولتی‌ویتامین، مکمل پنجاه‌هزار واحدی ویتامین D و کلسیم +ویتامین D
- بسته آموزش تغذیه ویژه مراقب سلامت
- مواد آموزشی جهت ارائه به گروه های هدف
- بسته خدمات تغذیه (ویژه مراقب سلامت، کارشناس تغذیه و پزشک)

مکمل‌های مورد نیاز گروه‌های سنی و فیزیولوژیک جهت ارائه توسط مراقبت سلامت

نام دارو	شکل دارو	گروه سنی	مقدار و طرز دادن دارو	به هر مراجعه کننده چقدر می توانید از این دارو بدهید
مولتی ویتامین یا ویتامین آ+د	قطره	شروع از روز ۳ تا ۵ تولد تا پایان ۲۴ ماهگی	روزانه یک سی سی قطره آ + د یا مولتی ویتامین	یک شیشه
مولتی ویتامین مینرال حاوی ۱۵۰ میکروگرم ید	قرص یا کپسول	مادران باردار؛ شروع از هفته ۱۶ بارداری تا ۳ ماه بعد اززایمان	روزی یک عدد	باتوجه به زمان مراجعه بعدی روزی یک عدد
	قرص یا کپسول	**مادران شیر.ده؛ روزی یک قرص تا سه ماه بعد از زایمان	روزی یک عدد	باتوجه به زمان مراجعه بعدی روزی یک عدد

آهن یا سولفات فرو	قطره	*** از پایان ۶ ماهگی تا پایان ۲۴ ماهگی	روزانه ۱ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن تا حداکثر ۱۵ میلی گرم آهن المنتال معادل ۱۵ قطره در روز	یک شیشه
	قرص	دختران نوجوان ۱۲ تا ۱۸ سال	هفته ای یک عدد به مدت ۱۶ هفته در طول هر سال تحصیلی	ارائه به مدارس بر اساس برنامه ریزی دانشگاه مربوطه
	قرص	مادران باردار؛ شروع از هفته ۱۶ بارداری تا پایان بارداری	روزی یک قرص	باتوجه به زمان مراجعه بعدی روزی یک عدد
	قرص	مادران شیرده؛ روزی یک قرص از زمان زایمان تا سه ماه بعد از زایمان	روزی یک عدد	باتوجه به زمان مراجعه بعدی روزی یک عدد

اسیدفولیک	قرص	به محض اطلاع از بارداری و یا ترجیحاً سه ماه قبل از شروع بارداری تا پایان بارداری **	روزی نصف قرص یک میلی گرمی	باتوجه به زمان مراجعه بعدی روزی یک عدد
ویتامین D (۵۰ هزار	پرل	نوجوانان سن مدرسه (۱۸-۱۲ سال)	ماهی یک عدد	باتوجه به زمان مراجعه بعدی ماهی یک عدد
واحدی)				
	پرل	میانسالان	ماهی یک عدد	باتوجه به زمان مراجعه بعدی ماهی یک عدد
	پرل	سالمندان	ماهی یک عدد	باتوجه به زمان مراجعه بعدی ماهی یک عدد
کلسیم/ کلسیم D (حاوی ۵۰۰ میلی گرم کلسیم/۴۰۰ یا ۵۰۰ واحد بین المللی ویتامین D)	قرص	***سالمندان	روزانه یک عدد	باتوجه به زمان مراجعه بعدی روزی یک عدد

RDA

- **RDA** یا **Recommended Dietary Allowance** مقدار مجاز توصیه‌شده روزانه) به میانگین میزان مصرف روزانه یک ماده مغذی گفته می‌شود که برای تأمین نیاز تقریباً تمام (۹۷ تا ۹۸ درصد) افراد سالم در یک گروه سنی و جنسی خاص کافی است.

TABLE 1 Recommended Dietary Allowances (RDAs) for Vitamin D

Age	Male	Female	Pregnancy	Lactation
0-12 months*	400 IU (10 mcg)	400 IU (10 mcg)	N/A	N/A
1-13 years	600 IU (15 mcg)	600 IU (15 mcg)	N/A	N/A
14-18 years	600 IU (15 mcg)	600 IU (15 mcg)	600 IU (15 mcg)	600 IU (15 mcg)
19-50 years	600 IU (15 mcg)	600 IU (15 mcg)	600 IU (15 mcg)	600 IU (15 mcg)
51-70 years	600 IU (15 mcg)	600 IU (15 mcg)	N/A	N/A
70 years	800 IU (20 mcg)	800 IU (20 mcg)	N/A	N/A

N/A, Not applicable.

*Adequate intake (AI)

Tolerable upper intake level (UL): 0-6 mos 25 mcg/d; 7-12 mos 38 mcg/d; 1-3y 63 mcg/d; 4-8y 75 mcg/d; 9-13y 100 mcg/d; 14-18y (also for pregnancy and lactation) 100 mcg/d; 19-50 (also for pregnancy and lactation) 100 mcg/d.

Recommended Dietary Allowances (RDAs) for Calcium

Age	Male	Female	Pregnancy	Lactating
0-6 months*	200 mg	200 mg		
7-12 months*	260 mg	260 mg		
1-3 years	700 mg	700 mg		
4-8 years	1000 mg	1000 mg		
9-13 years	1300 mg	1300 mg		
14-18 years	1300 mg	1300 mg	1300 mg	1300 mg
19-50 years	1000 mg	1000 mg	1000 mg	1000 mg
51-70 years	1000 mg	1200 mg		
71+ years	1200 mg	1200 mg		

*Adequate intake (AI)

Tolerable upper intake level (UL): 0-6 mos 1000 mg/d; 7-12 mos 1500 mg/d; 1-3y 2500 mg/d; 4-8y 2500 mg/d; 9-13y 3000 mg/d; 14-18y (also for pregnancy and lactation) 3000 mg/d; 19-50 (also for pregnancy and lactation) 2500 mg/d; 51+ 2000 mg/d.

Recommended Dietary Allowances (RDAs) for Iodine

Age	Male mcg/day	Female mcg/day	Pregnancy mcg/day	Lactation mcg/day
0-6 months	110*	110*	N/A	N/A
7-12 months	130*	130*	N/A	N/A
1-3 years	90	90	N/A	N/A
4-8 years	90	90	N/A	N/A
9-13 years	120	120	N/A	N/A
14-18 years	150	150	220	290
19+	150	150	220	290

N/A, Not applicable.

*Adequate intake (AI).

Tolerable upper intake level (UL): 0-12 mos not determined; 1-3y 200 mcg/d; 4-8y 300 mcg/d; 9-13y 600 mcg/d; 14-18y (also for pregnancy and lactation) 900 mcg/d; 19+ (also for pregnancy and lactation) 1,100 mcg/d.

Recommended Dietary Allowances for Iron for Children and Adults

Age	Male	Female	Pregnancy	Lactation
0-6 months	0.27 mg*	0.27 mg*		
7-12 months	11 mg	11 mg		
1-3 years	7 mg	7 mg		
4-8 years	10 mg	10 mg		
9-13 years	8 mg	8 mg		
14-18 years	11 mg	15 mg	27 mg	10 mg
19-50 years	8 mg	18 mg	27 mg	9 mg
51+ years	8 mg	8 mg		

*Adequate intake (AI)

Tolerable upper intake level (UL): 0-12 mos 40 mg; 1-3y 40 mg/d; 4-8y 119 mg/d; 9-13y 40 mg/d; 14-18y (also for pregnancy and lactation) 45 mg/d; 19+ (also for pregnancy and lactation) 45 mg/d.

در خصوص مکمل‌ها به نکات زیر توجه گردد:

* مکمل ها دور از دسترس کودکان قرار داده شود.

* فراورده های آهن را نباید به همراه شیر، چای، قهوه، دم کرده های گیاهی و داروهای ضد اسید مصرف کرد.

* مکمل ها در جای خنک و دور از نور نگهداری شود.

* توصیه می شوند قطره های آهن را ته دهان شیرخوار بچکانند و پس از هر بار مصرف به کودک کمی آب دهند و دندان های شیر خوار را با یک پارچه یا مسواک نرم پاک کرد.

* به زنان باردار آموزش داده شود که مکمل های آهن را حتما بعد از غذا و قبل از خواب مصرف کنند تا از بروز عواملی مانند سردرد و تهوع جلوگیری شود.

* میزان مصرف اسید فولیک در بارداری روزانه ۴۰۰ میکروگرم می باشد. بنابراین اگر قرص های موجود قابل نصف کردن هستند نصف قرص به صورت روزانه برای مادر باردار کافی است.

* مطابق دستورعمل مجموعه مراقبتهای ادغام یافته سلامت مادران بهتر است مصرف اسیدفولیک و یا اسیدفولیک همراه ید از سه ماه قبل از بارداری شروع شود(نسخه توسط پزشک).

* برای پیشگیری از کمبود ویتامین D در زنان باردار لازم است مطابق با دستور عمل مکمل یاری روزانه مادران باردار (۱۰۰۰واحد روزانه) اقدام شود.

* با توجه به شیوع بالای کمبود ویتامین D در جامعه قبل از ارائه مگادوز با دوز پیشگیری ماهانه یک عدد مکمل ۵۰۰۰۰ واحدی لزومی به اندازه گیری سرمی سطح ویتامین D نیست.

* با توجه به اینکه نوع تزریقی ویتامین D زیست دسترسی خوبی ندارند لذا برای پیشگیری از ویتامین D این شکل از مکمل توصیه نمی شود.

❋ به همراه ارائه مکمل ویتامین D لازم است کارکنان بهداشتی در نظام خدمات بهداشتی اولیه، به کلیه افراد توضحاتی در خصوص چگونگی مصرف و عوارض احتمالی ناشی از مصرف بیش از اندازه به شرح زیر ارائه دهد:

الف- بهتر از مکمل ویتامین د با وعده های اصلی غذا(ناهار یا شام)مصرف شود.

ب- دوز پیشگیری کننده ی فوق در کلیه افراد بدون عارضه می باشد.

ج- در صورت بروز علائم مسمومیت شامل یبوست، ضعف، خستگی، خواب آلودگی، سردرد، کاهش اشتها، پرنوشی، خشکی دهان از مصرف مکمل خوداری شود.

در موارد زیر ارجاع به پزشک مرکز ضروری است:

الف) موارد اثبات شده کمبود ویتامین "D" :در صورتی که با آزمایشات سرمی کمبود ویتامین د ثابت شود فرد باید جهت درمان به پزشک مرکز ارجاع داده شود.(سطح سرمی کمتر ۲۵میلی مول در لیتر)

خدمات و مراقبت‌های تغذیه‌ای طرح تحول نظام سلامت



- **مراقبین سلامت**
- **پزشکان**
- **کارشناسان تغذیه**

- **از کلیه این افراد انتظار می‌رود از شاخص‌ها و آمارهای بهداشتی و تغذیه‌ای در سطوح ملی، استانی و منطقه تحت پوشش و برنامه‌های بهبود تغذیه جامعه در کشور آگاهی داشته باشند.**
- **لازم است شرح وظایف هر گروه، به تفکیک در اتاق مربوطه نصب شده باشد.**

شرح وظایف مراقب سلامت

- اندازه‌گیری قد، وزن، دورسر و محاسبه نمایه توده بدنی برای مراجعین با استفاده از ابزار و تجهیزات استاندارد
- رسم منحنی‌های رشد کودک و نوجوان، منحنی وزن‌گیری مادران باردار و محاسبه نمایه توده بدنی بزرگسالان ۱۹ سال به بالا
- غربالگری و ارزیابی الگوی تغذیه
- تجویز مکمل‌های غذایی شامل: اسید فولیک، مولتی ویتامین مینرال ید دار، قرص و قطره آهن، قطره A+D، قطره مولتی‌ویتامین، مکمل پنجاه‌هزار واحدی ویتامین D و کلسیم
- تصمیم‌گیری در مورد وضعیت تغذیه و ارجاع به کارشناس تغذیه/پزشک مطابق با دستور عمل
- آموزش تغذیه صحیح براساس هرم و رهنمودهای غذایی با تاکید بر کاهش مصرف قند، نمک و چربی
- برآورد و درخواست به موقع مکمل‌ها، متون آموزشی و دیگر ابزار و ملزومات (مانند ترازو، قدسنج،کامپیوتر و ...) مورد نیاز جهت اجرای مراقبت‌های تغذیه‌ای
- تکمیل فرم‌های آماری خدمات، ارجاع و مراقبت‌های تغذیه‌ای مطابق با دستورعمل

برنامه‌های تغذیه‌ای جاری در نظام مراقبت‌های بهداشتی در ایران

- برنامه مشاوره و آموزش تغذیه‌ای

✔ مادر باردار، شیرده، کودک زیر 2 سال، کودک 5-2 سال، دیابت، فشار خون بالا، نوجوان، میانسال و سالمند

- برنامه مکمل‌یاری آهن و ویتامین D برای دختران دبیرستانی
- طرح حمایتی مشارکتی برای کودکان سوء تغذیه‌ای

وظایف کارشناس تغذیه در انجام مشاوره‌های فردی برای گروه‌های سنی

مادران باردار

۱- بررسی وضعیت آنتروپومتریک، تعیین میزان افزایش وزن مجاز طول بارداری

۲- بررسی و تفسیر آزمایشات بیوشیمیایی مادر باردار

۳- بررسی وضعیت دریافت انرژی و گروه های غذایی و ارائه توصیه متناسب با توجه به وضعیت آنتروپومتریک و آزمایشات فرد

۴- بررسی عوارض شایع دوران بارداری (تهوع و استفراغ، پره اکلامپسی، دیابت بارداری، یبوست، ادم، ریفلاکس معده به مری)

۴- توصیه به دریافت مکمل های تغذیه ای مورد نیاز

۵- ثبت در سیستم ناب و پیگیری دوره ای

•Preeclampsia

- پره‌اکلامپسی (Preeclampsia) یک اختلال جدی مرتبط با بارداری است که معمولاً پس از هفته بیستم بارداری بروز می‌کند و با فشار خون بالا و نشانه‌های آسیب به اندام‌ها مانند کلیه‌ها یا کبد مشخص می‌شود
- این بیماری در گذشته بیشتر با وجود **پروتئین در ادرار** (پروتئینوری) همراه با فشار خون بالا شناخته می‌شد. اما امروزه تشخیص آن گسترش یافته و حتی اگر پروتئین در ادرار نباشد، وجود نشانه‌های آسیب به اندام‌های حیاتی نیز برای تشخیص کافی است
- تنها **درمان قطعی** پره‌اکلامپسی، **زایمان** (ختم بارداری) است

علائم اصلی

- **علائم هشداردهنده** ممکن است شامل موارد زیر باشد:
- **تورم ناگهانی**: در دست‌ها، صورت به‌ویژه (اطراف چشم‌ها) یا پاها.
- **سردرد مداوم**: سردردی جدید که با مسکن معمولی (مثل استامینوفن) بهتر نمی‌شود.
- **تغییرات بینایی**: تاری دید، دیدن لکه‌های نورانی یا حساسیت به نور.
- **درد شکم**: به‌ویژه در ناحیه بالای شکم یا زیر دنده‌های راست (ناشی از آسیب کبد
- **تنگی نفس** یا کاهش ادرار.

مادران شیرده

۱- بررسی وضعیت آنتروپومتریک، تعیین میزان اضافه وزن یا کمبود وزن مادر

۲- بررسی و تفسیر آزمایشات بیوشیمیایی مادر شیرده

۳- بررسی وضعیت دریافت انرژی و گروه های غذایی و ارائه توصیه متناسب با توجه به وضعیت آنتروپومتریک و آزمایشات فرد

۴- توصیه به دریافت مکمل های تغذیه ای مورد نیاز

۶- مشاوره در رابطه با تغذیه اختصاصی کودک با شیر مادر تا ۶ ماهگی

۵- ثبت در سیستم ناب و پیگیری دوره ای

کودک زیر 2 سال



۱- بررسی وضعیت رشد (وزن، قد و دور سر)

۲- بررسی وضعیت دریافت تغذیه ای کودک و ارائه توصیه های متناسب به مادر

۳- توصیه به مصرف مکمل های مورد نیاز کودک براساس دستورالعمل های موجود

۴- مشاوره در رابطه با زمان و نحوه شروع تغذیه تکمیلی کودک

۵- ثبت در سیستم ناب و پیگیری دوره ای

کودک 2 تا 5 سال



۱- بررسی وضعیت آنتروپومتریک

۲- بررسی وضعیت دریافت تغذیه ای کودک و ارائه توصیه های متناسب

۳- توصیه به مصرف مکمل های مجاز در صورت نیاز

۴- ثبت در سیستم ناب و پیگیری دوره ای



افراد میانسال

۱- بررسی وضعیت آنتروپومتریک

۲- بررسی و تفسیر آزمایشات بیوشیمیایی در صورت موجود بودن

۳- ارائه مشاوره در صورت وجود اختلال

۴- بررسی وضعیت دریافت انرژی و گروه های غذایی و ارائه توصیه های متناسب با توجه به وضعیت آنتروپومتریک و آزمایشات فرد

۵- توصیه به دریافت مکمل های تغذیه ای مورد نیاز

۶- ثبت در سیستم ناب و پیگیری دوره ای

سالمندان



۱- بررسی وضعیت آنتروپومتریک

۲- بررسی و تفسیر آزمایشات بیوشیمیایی در صورت موجود بودن

۳- ارائه مشاوره در صورت وجود اختلال

۴- بررسی وضعیت دریافت انرژی و گروه های غذایی و ارائه توصیه های متناسب با توجه به وضعیت آنتروپومتریک و آزمایشات فرد

۵- توصیه به دریافت مکمل های تغذیه ای مورد نیاز

۶- ثبت در سیستم ناب و پیگیری دوره ای

اندازه‌گیری وزن و قد

- **وزن كودك يا نوجوان بايد در هنگام پذيرش اندازه‌گيري و بر حسب كيلوگرم ثبت شود. ابزار اندازه‌گيري بايد خصوصيات زير را داشته باشد:**

✔ **محكم و با دوام**

✔ **الكترونيكي داراي دقت اندازه گيري در حد 0/1 كيلو گرم (100 گرم)**

آمادگی برای توزین

- از همکار/ مادر بخواهید کفش و لباس‌هاي کودك یا پوشک او را درآورد. توضیح دهید که براي به دست آوردن وزن دقیق کودك، لازم است تا لباس‌هاي کودك، به جز زیرپوش وي درآورده شود. شیرخواران، باید برهنه وزن شوند و براي گرم نگهداشتن، تا زمان وزن کردن در پتو پیچیده شوند. براي کودکان بزرگتر، باید تمام لباس‌ها به جز لباس‌هاي زیر، درآورده شوند.

- حتي الامکان، اتاق گرم باشد و اگر هوا سرد است یا کودك در مقابل درآوردن لباس مقاومت مي‌کند، مي‌توان کودك را با لباس وزن کرد اما وزن آن‌ها باید از وزن کودك کم شود.

- اگر کودك وسایل زینتي مثل تِل یا کلیپس بر سر دارد که با اندازه‌گیري قد او به روش ایستاده یا خوابیده تداخل دارد، براي جلوگیري از تأخیر در اندازه‌گیري‌ها، قبل از وزن کردن کودك، در آورده شوند.

توزين كودک کوچکتر از 2 سال

- **اندازه گيري وزن کودکان زير 2 سال با ترازوي مخصوص کودکان که به آن ترازوي کفه اي گفته مي‌شود، انجام مي‌شود.**
- **معمولاً اين نوع ترازو روي ميز قرار داده مي‌شود و داراي کفه‌اي است که مخصوص گذاشتن کودك بر روي آن است و بسته به سن، کودك به حالت خوابيده و يا نشسته روي کفه قرار مي‌گيرد. در قسمت جلوي ترازو، ميله مدرجي است که وزنه روي آن قابل حرکت است. با حرکت دادن وزنه به طرف چپ و راست تعادل را بدست آورده و وزن کودك را بخوانيد.**
- **ترازويي که براي شيرخوار به کار مي‌بريم، بايد براي او راحت بوده و قبل از هر بار وزن کردن تنظيم شود.**
- **اطمينان حاصل شود که ترازو درست کار مي‌کند. حداقل در ابتداي هر شيفت و يکبار ديگر در طول روز ترازو با وزنه شاهد 500 گرمي کنترل شود. هميشه، قبل از توزين کودك ترازو صفر شود.**

ادامه‌ی توزین کودک کوچکتر از 2 سال...

- **روي ترازوي كفه‌اي، پارچه‌ي گرم انداخته شود تا از سرما، گريه و ناراحتي شيرخوار پيشگيري شود.**
- **از مادر بخواهيد تا كودك را به دقت و با ملايمت بر روي ترازو قرار دهد .**
- **شيرخوار بزرگتر از 7 - 8 ماه را مي‌توان در وضعيت نشسته وزن كرد.**
- **براي اطمينان از صحت توزين بايد در لحظه‌اي كه شيرخوار آرام است وزن كودك خوانده شود. براي اينكار، مي‌توان با اسباب بازي يا بازي با وي توجه او را جلب كرد و يا به مادر اجازه داد كه وقتي كودك بر روي ترازوي مخصوص توزين شيرخوار (ترازوي كفه اي) قرار دارد نزديک كودك باشد تا كودك آرام و ساكت باشد و شما آماده‌ي خواندن وزن كودك شويد.**
- **تكرار توزين، ضريب اعتماد را بالا مي‌برد.**
- **عدد درج شده را به درستي و با دقت بخوانيد و وزن كودك را ثبت كنيد.**


3.45


Original
Original-Mikro-Döll


seca



توزين كودک بزرگتر از 2 سال

- **اندازه‌گيري وزن کودکان بزرگتر از 2 سال با ترازوي سيار و يا ترازوي شاهين‌دار انجام مي‌شود که بايد بر روي سطح صاف گذاشته شود و کودک بدون کفش به حالت ايستاده روي ترازو قرار گيرد. اين کودکان مي‌توانند بايستند و شما مي‌توانيد آن‌ها را به تنهايي وزن کنيد.**
- **از مادر بخواهيد که در درآوردن کفش و لباس به کودک کمک کند.**
- **توجه به تنظيم بودن ترازو و دقيق بودن آن ضروري است. در طول روز چندين بار ترازو را با وزنه شاهد 2000 گرمي کنترل کنيد.**
- **از کودک بخواهيد در وسط ترازو بايستد.**
- **عدد درج شده وزن کودک را به درستي و با دقت و با صداي بلند بخوانيد و آن را ثبت کنيد.**



روش توزين كودكان زير دو سال همراه با مادر

- **لباس هاي كودك به جز زير پوش او را درآورده تا وزن صحيح او به دست آيد.**
- **شيرخواران بايد برهنه وزن شوند. براي گرم نگهداشتن، آنان را تا زمان وزن كردن در پتو بپيچيد.**
- **براي كودكان بزرگ تر، بايد تمام لباس‌ها به جز لباس‌هاي زير درآورده شوند.**
- **مطمئن شويد كه ترازو بر سطح صافي قرار دارد.**
- **در ترازو هاي نوري بايد نور كافي در محيط باشد.**
- **براي به كار انداختن ترازوي نوري، صفحه نوري آن را براي يک ثانيه بپوشانيد. وقتي كه اعداد 0.0 نمايان شد، ترازوآماده است.**
- **مادر بايد كفش‌هاي خود را درآورد.**
- **كودك برهنه پيچيده شده در پتو نگهداشته شود.**
- **مادر در وسط ترازو و برجاي مشخص شده قرار گيرد.**

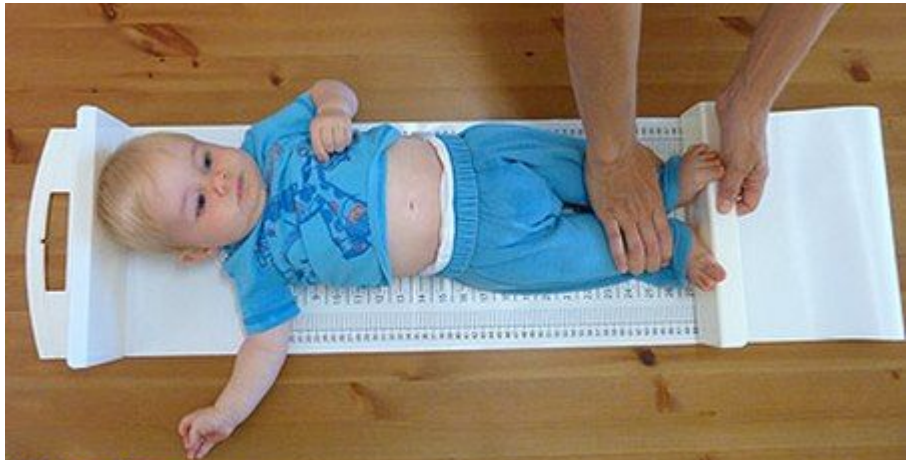
اندازه‌گيري قد كودكان و نوجوانان

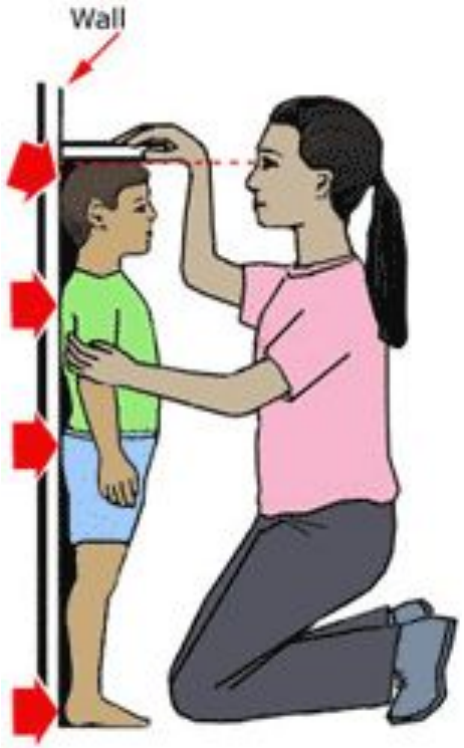
- **قد (سانتيمتر): قد كودك يا نوجوان بايد در هنگام پذيرش اندازه‌گيري و بر حسب سانتيمتر ثبت شود.**
- **بسته به سن و توانايي كودك در ايستادن، قد خوابيدهLength يا قد ايستاده Height كودك را اندازه‌گيري كنيد.**
- **اگر كودك كمتر از 2 سال دارد، قد خوابيده و اگر 2 سال يا بيشتر دارد و قادر به ايستادن است، قد ايستاده‌اش را اندازه بگيريد.**
- **قد ايستاده، حدود 0.7 سانتيمتر كمتر از قد خوابيده است. اگر كودك كمتر از 2 سال، براي اندازه‌گيري قد خوابيده، دراز نميكشد، قد ايستاده‌ي او را اندازه گرفته و 0.7 سانتيمتر به آن اضافه كنيد تا قد خوابيده به دست آيد و اگر كودك 2 ساله يا بزر گتر نتوانست بايستد، قد خوابيده‌ي او را اندازه‌گيري نموده و براي تبديل آن به قد ايستاده، 0.7 سانتيمتر از آن كم كنيد.**

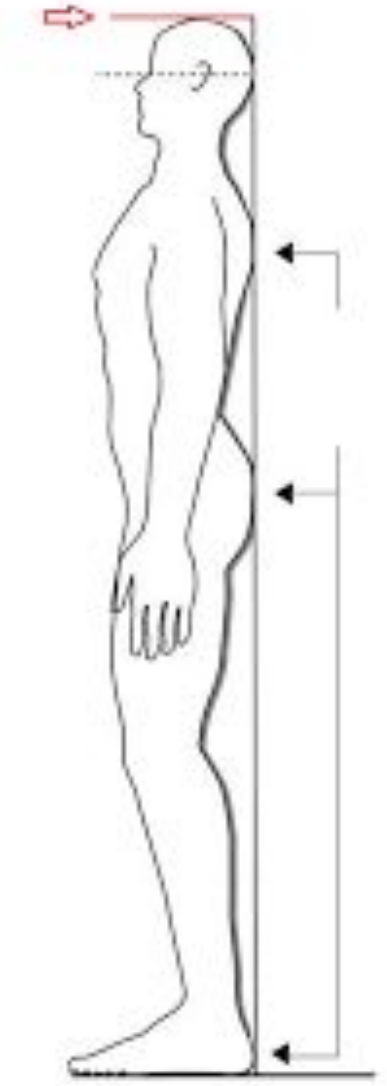
ادامه‌ی اندازه‌گيري قد كودكان و نوجوانان...

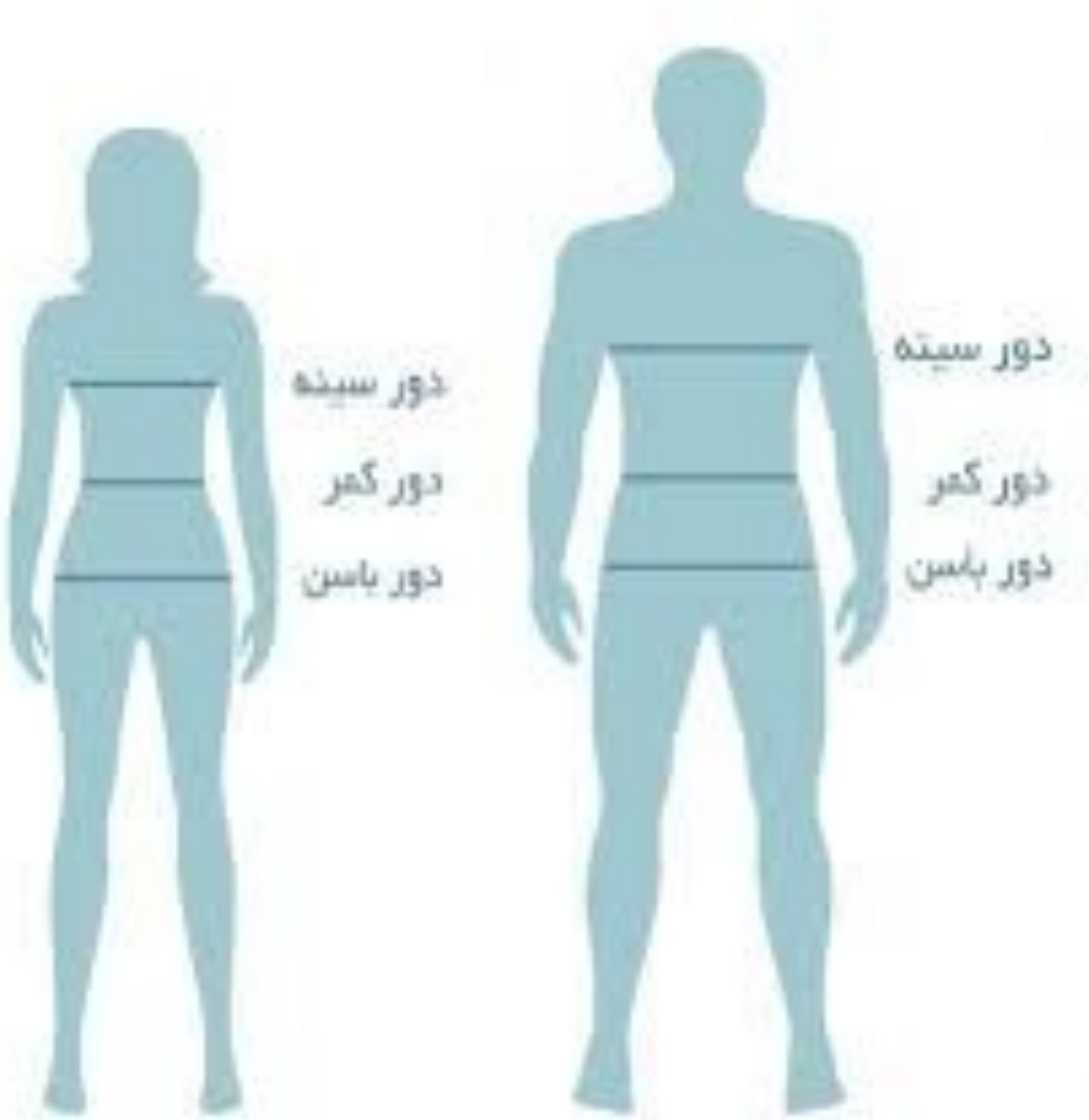
- **تخت قدسنج براي اندازه‌گيري قد خوابيده به كار مي‌رود. اين وسيله، بايد بر روي يک سطح صاف و محكم قرار گيرد.**
- **قدسنج براي اندازه‌گيري قد ايستاده به كار مي‌رود و به طور عمودي روي ديوار نصب مي‌شود.**
- **صفحات افقي و عمودي قدسنج‌ها بايد در زواياي صحيح به بدنه متصل شده باشند.**
- **قسمت متحرك در تخت قدسنج بخش پايي و در قدسنج ايستاده مربوط به قسمت سر است.**






Wall




دور سینه
دور کمر
دور باسن
دور سینه
دور کمر
دور باسن

برنامه‌های پیشگیری و کنترل کمبود ریزمغذی‌ها در ایران

- **کمبود ریزمغذی‌ها (آهن، روی، ویتامین A و D) از مشکلات تغذیه‌ای شایع در کشور است.**
- **در طی یک دهه گذشته، شیوع کم خونی و کمبود آهن در همه گروه‌های سنی به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است.**
- **کمبود ویتامین A و D در زنان باردار و کودکان زیر دو سال افزایش یافته است.**
- **یددار کردن نمک خوراکی مصرفی**

برنامه‌ی پیشگیری و کنترل اختلالات ناشی از کمبود ید

- **یددار کردن نمک های خوراکی**
- **سال 1370**
- **پایش نمک یددار در سه سطح تولید، عرضه و مصرف انجام می‌شود.**
- **آموزش همگانی در خصوص عدم مصرف نمک غیر استاندارد از جمله نمک دریا که فاقد ید کافی است و ناخالصی های زیاد از جمله فلزات سنگین دارد.**
- **اهمیت مصرف نمک یددار توسط مادران در دوره‌ی قبل از بارداری**

برنامه‌ی پیشگیری و کنترل کمبود آهن

- **آموزش جامعه به ویژه مادران باردار و شیرده، دختران سنین بلوغ در خصوص:**
- **اهمیت مصرف مکمل آهن**
- **نحوه‌ی صحیح مصرف و مقدار مکمل**
- **آموزش تغذیه و معرفی منابع غذایی آهن دار، افزایش دهنده‌ها و کاهش دهنده‌های جذب آهن در برنامه‌ی غذایی**
- **اهمیت دادن قطره آهن به کودکان زیر 2 سال**

برنامه غنی‌سازي با آهن و اسید فولیک

- **غنی سازی آرد با آهن و اسید فولیک یک استراتژی ارزان**
- **سال 1380 در بوشهر آغاز و به تدریج در سایر استان ها اجرا شد.**
- **برنامه ملی غنی سازی آرد در سال 1386 تدوین و در سطح کشور به مورد اجرا گذاشته شده است.**
- **آموزش مردم در زمینه ی فواید مصرف نان غنی شده با آهن و اسید فولیک ، کمبود آهن و کم خونی ناشی از آن و پیشگیری از آن با مصرف نان غنی شده توسط کارکنان بهداشتی به طرق مختلف باید انجام شود.**

پیشگیری و کنترل کمبود ویتامین A و D

- **اقدامات زیر باید برای پیشگیری و کنترل کمبود ویتامین A در کشور انجام شود:**
- **مکمل یاری برای کلیه‌ی کودکان، آموزش و مشاوره با مادر در زمینه‌ی منابع غذایی ویتامین A و مقدار و نحوه‌ی مصرف مکمل و زمان شروع و دوره‌ی استفاده‌ی آن**
- **پایش و نظارت بر اجرای برنامه مکمل‌یاری ویتامین D و آهن‌یاری هفتگی دختران دبیرستانی طبق دستورالعمل**
- **آموزش مدیران و معلمین، دانش آموزان و اولیا آن ها در زمینه ی کمبود ویتامینD و راه‌های پیشگیری از آن**
- **پایش و نظارت بر اجرای برنامه مکمل‌یاری ویتامین D مادران باردار، جوانان، میانسالان و سالمندان طبق دستورالعمل‌ها**

- برنامه کنترل و پیشگیری دیابت
- برنامه کنترل و پیشگیری از سرطان
- برنامه کنترل و پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی
- برنامه کنترل و پیشگیری از فشار خون
- برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر
- برنامه تغذیه ای مراقبت از مادران شیرده
- برنامه تغذیه ای مراقبت از مادران باردار
- برنامه تغذیه ای مراقبت از کودکان زیر 6 سال